認定結果(テスト用設定)

テスト用架空事例

要介護度	要介護5
認定日	令和8年9月8日(テスト用)
認定の有効期間	令和8年10月1日～令和11年9月30日(36か月) (テスト用)

認 定 調 査 票 (概 況 調 査)

Ⅰ 調査実施者(記入者)

実施日時	令和8年8月18日 (テスト用)
実施場所	自宅
記入者氏名・所属	＊＊＊＊(テスト用)

Ⅱ 調査対象者

過去の認定	更新申請(前回:要介護5)		
対象者氏名	坂口 勝治 (さかぐち かつじ)	性別	男
生年月日	昭和15年(1940年)1月12日	年齢	86歳
現住所	○○県○○市＊＊＊＊(テスト用)		
家族等連絡先	＊＊＊＊(テスト用)		

Ⅲ 現在受けているサービスの状況

介護給付 訪問介護(身体介護・1日2回)、訪問看護(週2回・胃ろうの管理と褥瘡予防)、訪問入浴介護(週2回)、短期入所療養介護(月7日)、福祉用具貸与(特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・車いす)。医療 訪問診療(月2回)。

Ⅳ 置かれている環境等(調査対象者の家族状況、調査対象者の居住環境、日常的に使用する機器・器械の有無等)

家族状況	妻(84歳)と二人暮らし。主な介護者は妻だが、腰痛があり体力的に限界に近い。長男(58歳)は車で10分のところに住み、朝晩に立ち寄る。
居住環境	平屋の持ち家。居間に介護ベッドを置いている。
使用している機器等	特殊寝台、床ずれ防止用具(エアマット)、体位変換器、リクライニング車いす、胃ろう(経管栄養)、紙おむつ。
生活歴	役場に勤め、退職後は地区の自治会長を長く務めた。
本人・家族の主訴	本人:発語がなく、意向は確認できない。 妻:「できるだけ家で看たいが、自分の体がもつか心配。」 長男:「母に無理をさせたくない。ショートステイも続けたい。」

認定調査票(基本調査)

テスト用架空事例

該当する選択肢を〇で囲んでいます。

第1群 身体機能・起居動作	
1-1 麻痺等の有無 (複数選択可)	ない　左上肢 (右上肢) 左下肢 (右下肢) その他(四肢の欠損)
1-2 拘縮の有無 (複数選択可)	ない (肩関節) (股関節) (膝関節) その他(四肢の欠損)
1-3 寝返り	つかまらないでできる　何かにつかまればできる (できない)
1-4 起き上がり	つかまらないでできる　何かにつかまればできる (できない)
1-5 座位保持	できる　自分の手で支えればできる　支えてもらえればできる (できない)
1-6 両足での立位保持	支えなしでできる　何か支えがあればできる (できない)
1-7 歩行	つかまらないでできる　何かにつかまればできる (できない)
1-8 立ち上がり	つかまらないでできる　何かにつかまればできる (できない)
1-9 片足での立位	支えなしでできる　何か支えがあればできる (できない)
1-10 洗身	介助されていない　一部介助 (全介助) 行っていない
1-11 つめ切り	介助されていない　一部介助 (全介助)
1-12 視力	普通(日常生活に支障がない)　約1m離れた視力確認表の図が見える 目の前に置いた視力確認表の図が見える　ほとんど見えない (見えているのか判断不能)
1-13 聴力	普通　普通の声がやっと聞き取れる　かなり大きな声なら何とか聞き取れる ほとんど聞えない (聞えているのか判断不能)
第2群 生活機能	
2-1 移乗	介助されていない　見守り等　一部介助 (全介助)
2-2 移動	介助されていない　見守り等　一部介助 (全介助)
2-3 えん下	できる　見守り等 (できない)
2-4 食事摂取	介助されていない　見守り等　一部介助 (全介助)
2-5 排尿	介助されていない　見守り等　一部介助 (全介助)
2-6 排便	介助されていない　見守り等　一部介助 (全介助)
2-7 口腔清潔	介助されていない　一部介助 (全介助)
2-8 洗顔	介助されていない　一部介助 (全介助)
2-9 整髪	介助されていない　一部介助 (全介助)
2-10 上衣の着脱	介助されていない　見守り等　一部介助 (全介助)
2-11 ズボン等の着脱	介助されていない　見守り等　一部介助 (全介助)
2-12 外出頻度	週1回以上 (月1回以上) 月1回未満
第3群 認知機能	
3-1 意思の伝達	調査対象者が意思を他者に伝達できる　ときどき伝達できる ほとんど伝達できない (できない)
3-2 毎日の日課を理解	できる (できない)
3-3 生年月日や年齢を言う	できる (できない)
3-4 短期記憶	できる (できない)
3-5 自分の名前を言う	できる (できない)
3-6 今の季節を理解する	できる (できない)
3-7 場所の理解	できる (できない)
3-8 徘徊	(ない) ときどきある　ある

3-9 外出すると戻れない	(ない)　ときどきある　ある　テスト用架空事例
第4群 精神・行動障害	
4-1 物を盗られたなどと被害的になる	(ない)　ときどきある　ある
4-2 作話	(ない)　ときどきある　ある
4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる	(ない)　ときどきある　ある
4-4 昼夜の逆転がある	(ない)　ときどきある　ある
4-5 しつこく同じ話をする	(ない)　ときどきある　ある
4-6 大声をだす	(ない)　ときどきある　ある
4-7 介護に抵抗する	(ない)　ときどきある　ある
4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない	(ない)　ときどきある　ある
4-9 一人で外に出たがり目が離せない	(ない)　ときどきある　ある
4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる	(ない)　ときどきある　ある
4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする	(ない)　ときどきある　ある
4-12 ひどい物忘れ	(ない)　ときどきある　ある
4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする	(ない)　ときどきある　ある
4-14 自分勝手に行動する	(ない)　ときどきある　ある
4-15 話がまとまらず、会話にならない	(ない)　ときどきある　ある
第5群 社会生活への適応	
5-1 薬の内服	介助されていない　一部介助　(全介助)
5-2 金銭の管理	介助されていない　一部介助　(全介助)
5-3 日常の意思決定	できる(特別な場合でもできる)　特別な場合を除いてできる　日常的に困難　(できない)
5-4 集団への不適応	(ない)　ときどきある　ある
5-5 買い物	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
5-6 簡単な調理	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)

その他 過去14日間に受けた特別な医療

□点滴の管理　□中心静脈栄養　□透析　□ストーマ(人工肛門)の処置　□酸素療法　□レスピレーター(人工呼吸器)
□気管切開の処置　□疼痛の看護　■経管栄養　□モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)　□じょくそうの処置
□カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

日常生活自立度

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)	自立　J1　J2　A1　A2　B1　B2　C1　(C2)
認知症高齢者の日常生活自立度	自立　Ⅰ　Ⅱa　Ⅱb　Ⅲa　Ⅲb　(Ⅳ)　M

認定調査票(特記事項)

テスト用架空事例

第1群 身体機能・起居動作	1-1 右上下肢に麻痺がある。1-2 両肩・股・膝関節に拘縮がある。 1-3〜1-9 自分では寝返りもできない。2時間ごとに体位を変えている。 1-12・1-13 呼びかけに目を開けることはあるが、見えているか、聞こえているかは確認できない。
第2群 生活機能	2-3 飲み込みができず、口から食べていない。2-4 栄養はすべて胃ろうから注入している(1日3回)。 2-5・2-6 おむつを使用。 2-12 月7日の短期入所療養介護に、介護タクシーで出かける。
第3群 認知機能	3-1〜3-7 発語がなく、意思の伝達や質問への応答はできない。
第4群 精神・行動障害	特記すべき行動はない。
第5群 社会生活への適応	5-1〜5-6 すべて妻と長男が行っている。
特別な医療	経管栄養:胃ろうから1日3回、栄養剤を注入している。注入は妻と訪問介護員(研修修了者)が行い、訪問看護師が胃ろう周囲の皮膚と注入の状態を確認している。

主 治 医 意 見 書

テスト用架空事例

申請者	坂口 勝治 (男・86歳) 医療機関名・医師氏名:＊＊＊＊(テスト用)

1. 傷病に関する意見

(1)診断名	発症年月日
1. 脳出血後遺症(右片麻痺・失語)	令和4年5月
2. 嚥下障害(胃ろう造設)	令和4年8月
3. 高血圧症	約30年前
(2)症状としての安定性	安定
(3)経過及び治療内容	令和4年5月に左被殻出血を発症し、右片麻痺と重度の失語が残った。嚥下障害のため令和4年8月に胃ろうを造設。以後、寝たきりの状態で、全身状態は安定している。 処置・投薬:胃ろうからの経管栄養(1日3回)、降圧薬、胃ろうの交換(6か月ごと、訪問診療で実施)。

2. 特別な医療(過去14日間以内に受けた医療)

経管栄養

3. 心身の状態に関する意見

(1)日常生活の自立度等	障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度):C2 認知症高齢者の日常生活自立度:Ⅳ
(2)認知症の中核症状	短期記憶:問題あり/日常の意思決定:判断できない/意思の伝達:伝えられない
(3)認知症の行動・心理症状	なし
(4)その他の精神・神経症状	失語(重度)
(5)身体の状態	利き腕:右/身長163cm・体重47kg/麻痺:右上肢・右下肢(重度)/関節の拘縮:両肩・股・膝/褥瘡なし(過去に仙骨部の褥瘡あり、治癒)

4. 生活機能とサービスに関する意見

(1)移動	屋外歩行:していない/車いす:主に他人が操作(リクライニング車いす)/歩行補助具:使用していない
(2)栄養・食生活	食事行為:全面介助(胃ろう)/栄養状態:やや不良/留意点:注入時の体位(上半身を30度以上起こす)
(3)現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針	褥瘡の再発、誤嚥性肺炎、胃ろうのトラブル、介護者の疲労 → 体位変換と床ずれ防止用具、口腔ケア、短期入所による介護者の休息
(4)サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し	期待できない
(5)医学的管理の必要性	訪問診療、訪問看護
(6)サービス提供時における医学的観点からの留意事項	経管栄養:注入中と注入後30分は上半身を起こす/皮膚:仙骨部・かかとの観察/口腔:口腔ケアで誤嚥性肺炎を予防
(7)感染症の有無	なし

5. 特記すべき事項

全身状態は安定しているが、すべての生活動作に全介助を要する。主介護者の妻は高齢で腰痛があり、介護力に限界がある。訪問系サービスと短期入所の継続が必要。